



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN HASIL SURVEY
BUDAYA KESELAMATAN
PASIEN**

**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

TAHUN 2024

Jl. Raya Surabaya – Malang No. KM 54, Surabaya – Pasuruan

Telp. 08341 – 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



Pasuruan, 29 Januari 2024

Nomor : 111/RSPHS/I-PM/KMKP/I/2024
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Ijin Survey Budaya Keselamatan Pasien Tahun 2024

Kepada Yth.

Direktur RS Prima Husada Sukorejo

Di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, maka bersama dengan ini Komite Mutu mengajukan ijin pelaksanaan **Survey Budaya Keselamatan Pasien Tahun 2024** menggunakan media google form yang akan dilaksanakan pada 05 Februari 2024. Sasaran pada survey ini adalah seluruh staff RS. Prima Husada Sukorejo, adapun hasil dari kegiatan survey ini akan dilaporkan kepada pimpinan maksimal dua minggu setelah tanggal pelaksanaan.

Demikian surat permohonan surat ijin survey ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Bening Sekar Tanjung, S.KM

LEMBAR PENGESAHAN

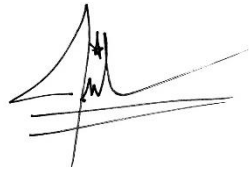
Survey Budaya Keselamatan Pasien

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2024

Hasil survey budaya keselamatan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Disusun,

Oleh :



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui,

Direktur RS. Prima Husada Sukorejo



(dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Umum 1

1.1 Tujuan Khusus 1

BAB II..... 2

METODE SURVEY 2

2.2 Bahan dan Metode 2

BAB III..... 3

HASIL KEGIATAN 3

3.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 3

3.2 Gambaran Karakteristik Responden..... 3

3.3 Gambaran Dimensi Budaya Keselamatan Pasien..... 6

3.5 Grafik Dimensi Survey Budaya Keselamatan Pasien 16

3.6 Saran Responden..... 16

BAB V 17

PENUTUP 17

5.1 Kesimpulan..... 17

5.2 Saran 17

KATA PENGANTAR

Keselamatan Pasien/KP (Patient Safety) merupakan issue Global dan Nasional bagi rumah sakit dan merupakan komponen penting dari mutu pelayanan kesehatan, serta merupakan prinsip dasar dalam pelayanan pasien dan komponen kritis dalam manajemen mutu (WHO, 2004). Perhatian dan Fokus terhadap Keselamatan Pasien ini didorong oleh masih tingginya angka kejadian Tak Diinginkan (KTD) atau *Adverse Event* (AE) di rumah sakit baik secara global maupun nasional.

Sebagai upaya memecahkan masalah tersebut dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih aman diperlukan suatu perubahan budaya dalam pelayanan kesehatan maka dilakukannya survey budaya keselamatan pasien uni untuk mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien yang dilakuka oleh staf Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Assesmen dalam survey ini menggambarkan tingkat budaya keselamatan pasien dalam satu waktu tertentu saja sehingga membutuhkan pengulangan assesmen secara berkala untuk menilai perkembangannya. Dengan adanya survey budaya keselamatan pasien ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan mengenai kepatuhan staf dalam menjalankan budaya keselamatan pasien.

Pasuruan, 14 Februari 2024

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit akan memberikan dampak yang merugikan bagi pihak Rumah Sakit, Staff, dan pasien sebagai penerima pelayanan. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit. Untuk meminimalisir terjadinya Kejadian yang tidak diharapkan terkait dengan aspek keselamatan pasien, maka manajemen Rumah Sakit perlu menciptakan budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien merupakan pondasi utama dalam menuju keselamatan pasien, dengan adanya perilaku membudaya keselamatan pasien secara signifikan akuntabilitas Rumah Sakit di mata pasien dan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya kinerja Rumah Sakitpun meningkat.

Pada umumnya seluruh Rumah Sakit sudah mengaplikasikan system keselamatan yang baik, tetapi pada kenyataannya insiden terkait pasien tetap terjadi namun insiden dapat ditekan sekecil-kecilnya. Namun, faktanya system tidak dapat berjalan secara optimal jika kompetensi dan nilai-nilai budaya yang ada tidak mendukung. Penerapan budaya keselamatan pasien akan mendatangkan keuntungan bagi pasien dan pihak pelayanan kesehatan. Dengan adanya penerapan budaya keselamatan kesalahan yang terjadi akan terdeteksi kesalahan yang terjadi atau yang akan terjadi. Selain itu, penerapan budaya keselamatan pasien akan meningkatkan kesadaran staff untuk mencegah *error*, meningkatkan budaya lapor jika terjadi kesalahan di unit kerja dan menengurangi pengeluaran finansial yang diakibatkan oleh kejadian keselamatan pasien (Carthey & Clarke dalam Beginta, 2021)

Budaya keselamatan pasien menurut *Association Health Care and Research Quality* (AHRQ) dapat diukur dari segi perspektif staff Rumah Sakit yang terdiri dari 12 dimensi yaitu : harapan dan tindakan manajer mempromosikan keselamatan pasien, *organizational learning* – perbaikan berkelanjutan, kerjasama dalam unit, komunikasi terbuka, umpan balik dan komunikasi mengenai kesalahan, respon *non-punitive* terhadap kesalahan, *staffing*, dukungan manajemen terhadap upaya keselamatan pasien, kerjasama antar unit di Rumah Sakit terkait keselamatan pasien, dan frekuensi pelaporan kejadian (AHRQ, 2004)

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang tercantum di Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes/SK/II/2008, menjelaskan bahwa di Rumah Sakit tidak boleh ada kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Sedangkan di RS Prima Husada Sukorejo berdasarkan data insiden keselamatan pasien pada bulan Januari sampai september tahun 2024 masih terdapat insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit yaitu insiden yang menyebabkan kematian atau sentinel, KNC maupun KTD. Melihat masih banyaknya masalah keselamatan pasien di RS Prima Husada Sukorejo dan pentingnya penerapan budaya keselamatan pasien, maka dilakukan pengukuran atau survei budaya keselamatan pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada seluruh staff di Rumah sakit.

1.2 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambar budaya keselamatan pasien pada staf RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2024

1.3 Tujuan Khusus

- 1.3.1.** Mengukur budaya keselamatan pasien di RS Prima Husada Sukorejo.
- 1.3.2.** Mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien di setiap unit RS Prima Husada Sukorejo.
- 1.3.3.** Melaksanakan program pencegahan terkait Insiden Keselamatan Pasien di RS Prima Husada Sukorejo.
- 1.3.4.** Mengevaluasi efektivitas intervensi keselamatan pasien dari waktu ke waktu.

BAB II METODE SURVEY

2.1. Bahan dan Metode

Survey ini dilaksanakan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Februari 2024. Survey ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam survey ini adalah seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan jumlah keseluruhan populasi adalah 506 staff. Survey ini dilakukan melalui pengisian google form yang dikirimkan pada setiap kepala ruangan dengan jumlah sampel yang didapatkan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$
$$= \frac{506}{1+506 (0.1)^2} = \frac{506}{1+506 (0.01)} = 93 \text{ sasaran}$$

Alat pengumpulan data dalam survey ini adalah kuesioner Budaya Keselamatan Pasien yang di adopsi dari Kuesioner *Hospital Survey on Patient Safety Culture* dipublikasikan oleh *The Agency for Health care Research and Quality* tahun 2019. Instrumen kuesioner ini terdiri dari 38 pernyataan yang mencakup 10 dimensi budaya keselamatan pasien yang di desain untuk semua staff. data survey ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif menggunakan computer dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi disertai narasi.

BAB III HASIL KEGIATAN

3.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai pelayanan kesehatan memiliki peran aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat pada umumnya dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Hal tersebut tercermin dalam visi, misi dan motto Rumah Sakit Prima Husada Sebagai Berikut:

1. Visi
Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat
2. Misi
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
 - b. Mengutamakan kepuasan pasien
 - c. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
3. Motto
Sahabat menuju sehat

Rumah sakit prima husada sukorejo memiliki prinsip khusus untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan landasan 7 Nilai budi utama, yakni:

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. peduli

3.2 Gambaran Karakteristik Responden

Jumlah populasi survey berjumlah 506 staff, dengan sasaran staf yang mengisi kuesioner adalah 93 staf. Adapun karakteristik responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Gambaran Karakteristik Responden

No	Kategori Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	17 – 25 Tahun	31	33%
2	26 – 35 Tahun	49	53%
3	36 – 45 Tahun	10	11%
4	46 – 55 Tahun	2	2%
5	56 – 65 Tahun	1	1%
Jumlah		93	100%

Jika melihat hasil survey pada tabel 3.1 mayoritas tenaga kesehatan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berusia 26-35 tahun sebesar 53% dan usia terendah 56-65 tahun sebesar 1%.

Tabel 3.2 Gambaran Karakteristik Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – Laki	38	41%
2	Perempuan	55	59%
Jumlah		93	100%

Mayoritas responden yang mengisi survey budaya keselamatan pasien yakni staff perempuan dengan presentase 59%.

Tabel 3.3 Gambaran Pendidikan Terakhir Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA / SMK	21	23%
2	D3 / D4	36	39%
3	S1 / S2 / S3	36	39%
Jumlah		93	100%

Bila melihat tingkat pendidikan staff di rumah sakit memiliki pendidikan minimal SMK/SMA yaitu 23% dan mayoritas staff berpendidikan DIII-DIV / S1-S2-S3 serta profesi keperawatan, proesi apoteker, sedangkan dokter berpendidikan dokter umum dan spesialis yang akan mentaati kode etik. Berdasarkan latarbelakang pendidikan tersebut diharapkan staff mampu berkoomunikasi dengan pasien dan keluarga, serta mampu memanfaatkan sarana kesehatan yang tersedia secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 3.4 Gambaran Lokasi Kerja Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pelayanan	75	81%
2	Non Pelayanan	18	19%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.5 Gambaran Ketersediaan Pelatihan Patient Safety

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	88	95%
2	Tidak	5	5%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.6 Gambaran Partisipasi Staff dalam Pelatihan Patient Safety

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	87	94%
2	Tidak	6	6%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.7 Gambaran Persepsi Staff tentang Sistem Pelaporan IKP

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	86	92%
2	Kurang	7	8%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.8 Gambaran Persepsi staff tentang Sifat Pelaporan Insiden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	25	27%
2	Tidak	68	73%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.9 Gambaran Pembelajaran Staff dari IKP yang sudah Terjadi

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	90	97%
2	Tidak	3	3%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.10 Gambaran Kepatuhan Staff dalam Melaporkan IKP ke Otoritas Lebih Tinggi

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	80	86%
2	Tidak	13	14%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.11 Gambaran Posisi Responden di Rumah Sakit

No	Posisi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dokter (Umum, gigi, spesialis)	7	7,5%
2	Perawat Vokasi	16	24,7%
3	Perawat profesi	30	32,3%
4	Bidan	2	2,2%
5	Farmasi / Apoteker	1	1,1%
6	Analisis Kesehatan	5	5,4%
7	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan masyarakat	1	1,1%
8	Cleaning Service	15	16,1%

9	IPSRs (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)	1	1.1%
10	Security	3	3,2%
15	CSSD/Laundry	4	4,3%
16	Admin unit, sekretaris, resepsionis, staf kantor	4	4,3%
19	Direktur, Wakil direktur, kepala bidang, manajer	2	2,2%
Jumlah		93	100%

3.12 Gambaran Unit Kerja Responden

No	Posisi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Instalasi rawat jalan	5	5,4%
2	Instalasi rawat inap 2A	2	2,1%
3	Instalasi rawat inap 2B	2	2,1%
4	Instalasi rawat inap 3A	16	17,2%
5	Instalasi rawat inap 3B	5	5,4%
6	Instalasi Care Unit	13	14,0%
7	Instalasi Gawat Darurat	5	5,4%
8	Instalasi Farmasi	2	2,1%
9	Laboratorium	5	5,4%
10	Radiologi	3	3,2%
11	Instalasi Rekam Medis, pendaftaran	1	1,1%
11	IKO	4	4,3%
12	Bagian SDM, diklat	1	1,1%
13	Neonatologi	2	2,1%
14	Bagian Akuntansi	1	1,1%
15	Maternitas	3	3,2%
16	Bagian Keamanan	1	1,1%
17	Cleaning service, Taman dan statuan pengamanan	14	15,1%
18	Manajemen	3	3,2%
19	B3	1	1,1%
20	Humas & Marketing	1	1,1%
21	CSSD	1	1,1%
22	Komite	2	2,1%
Jumlah		93	100%

Jika melihat tenaga medis dan non medis yang mengisi kuesioner ini, perawat merupakan responden terbanyak yaitu 46 orang. Tenaga professional tersebut yang melaksanakan tugas di unit rawat jalan dan rawat inap dan merupakan profesional asuhan yang berinteraksi langsung dengan pasien, sehingga harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan tindakan maupun pemeriksaan terhadap pasien, berusaha untuk meminimalisir kesalahan, menghindari komplain dan lebih mengutamakan keselamatan pasien.

Tabel 3.13 Deskripsi Lama Kerja Responden di Rumah Sakit

No	Lama Kerja	Jumlah Tanggapan	Persentase (%)
1	< 1 tahun	20	21.5%
2	1-5 tahun	68	73.10%
3	6-10 tahun	4	4.30%
4	> 11 tahun	1	1.10%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.14 Deskripsi Lama Kerja Responden di Unit

No	Lama Kerja	Jumlah Tanggapan	Persentase (%)
1	< 1 tahun	29	31.20%
2	1-5 tahun	61	65.50%
3	6-10 tahun	2	2.20%
4	> 11 tahun	1	1.1%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.15 Deskripsi Jam Kerja Responden di Unit

No	Response	Jumlah Tanggapan	Persentase (%)
----	----------	------------------	----------------

1	< 30 jam / minggu	12	12.90%
2	30-40 jam / minggu	34	36.60%
3	> 40 jam / minggu	47	50.50%
Jumlah		93	100%

Tabel 3.16 Deskripsi Berdasarkan Keterlibatan Kontak dengan Pasien

No	Response	Jumlah Tanggapan	Persentase (%)
1	Ya	73	78.50%
2	Tidak	20	21.50%
Jumlah		93	100.0%

Responden yang memiliki masa kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 1-5 tahun merupakan responden terbanyak yaitu 68 orang, dan masa kerja di unit 1-5 tahun sebanyak 61 orang dengan mayoritas responden kontak dengan pasien sebanyak 73 orang. Sebagian besar responden memiliki waktu kerja dalam seminggu >40 jam sebanyak 47 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah cukup lama menjalankan profesinya, sehingga semakin banyak kasus yang ditanganinya. Hal tersebut akan menambah pengalaman dan meingkatkan keahlian dan keterampilan kerja.

3.3 Gambaran Dimensi Budaya Keselamatan Pasien

Pada bagian ini disajikan gambaran secara kuantitatif 10 dimensi budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Suatu budaya keselamatan pasien dikatakan budaya baik apabila respon positif sebesar $\geq 75\%$ atau tinggi, budaya sedang apabila respon positif sebesar 50%-75%, dikatakan budaya rendah apabila respon positif $\leq 50\%$. Respon positif adalah jawaban berupa setuju/sering dan sangat setuju / selalu pada pernyataan positif, dan jawaban negative tidak setuju / jarang dan sangat tidak setuju/tidak pernah pada pernyataan negative.

1. Dimensi Umpan Balik & Komunikasi Tentang Kesalahan

Tabel 3.17 Dimensi Umpan Balik & Komunikasi Tentang Kesalahan

No	Tiga hal yang mengukur komunikasi tentang kesalahan	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sebagian besar atau selalu	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon tidak pernah atau jarang	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item C1- Kata Positif				
	Kami diberitahu tentang kesalahan yang terjadi di unit ini	91	2	93	97.85%
2	Item C2- Kata Positif				
	Ketika kesalahan terjadi di unit ini, kami membahas bagaimana cara untuk mencegah terulang kembali	93	0	93	100%
3	Item C3- Kata Positif				
	Di unit ini, kami diberitahu tentang perubahan yang dibuat berdasarkan laporan insiden	90	3	93	96.77%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					98.21%

Pada dimensi umpan balik dan komunikasi terhadap kesalahan hasil survey menunjukkan respon positif responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan mengenai pemberian informasi mengenai kesalahan yang terjadi di unitnya, dan dilakukan diskusi bersama untuk membahas masalah tersebut sehingga dapat

dirumuskan tindaklanjut untuk perubahan unit. Rata-rata respon positif pada dimensi ini sebesar 98.21% yang dikategorikan tinggi. Umpan balik dan komunikasi terhadap kesalahan merupakan hal yang terpenting setelah dilakukannya pelaporan insiden keselamatan pasien. Salah satu dari prinsip inti dalam pelaporan kejadian adalah pelaporan hanya bisa memberi manfaat apabila direspon secara konstruktif. Paling tidak terdapat umpan balik dari analisis temuan. Umpan balik dari organisasi dan rekan satu tim merupakan bentuk dari pembelajaran organisasi. Setiap pelaporan insiden selalu diberikan umpan balik oleh pihak manajemen sebagai bahan perbaikan ke arah lebih baik untuk unit terkait.

2. Dimensi Keterbukaan Komunikasi

Tabel 3.18 Dimensi Keterbukaan Komunikasi

No	Empat hal yang mengukur keterbukaan komunikasi	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sebagian besar atau selalu	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon tidak pernah atau jarang	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item C4- Kata Positif				
	Di unit ini, anda akan berbicara jika mereka melihat sesuatu yang dapat mempengaruhi perawatan pasien secara negatif	85	8	93	91.40%
2	Item C5- Kata Positif				
	Saat staf di unit ini melihat seseorang dengan kewenangan yang lebih melakukan sesuatu yang tidak aman bagi pasien, maka staf berani mengingatkan	90	3	93	96.77%
3	Item C6- Kata Positif				
	Ketika staf di unit ini mengingatkan, mereka yang memiliki kewenangan lebih terbuka terhadap masalah keselamatan pasien mereka	90	3	93	96.77%
4	Item C7- Kata Negatif				
	Di unit ini, karyawan takut mengajukan pertanyaan ketika ada yang tidak benar terjadi	25	68	93	73.12%
Persentase respon positif rata-rata di 4 item					89.52%

Pada dimensi keterbukaan komunikasi dihasilkan rata-rata respon positif petugas sebanyak 89.52% yang artinya dimensi keterbukaan komunikasi dalam kategori tinggi. Keterbukaan komunikasi antara staff dan pimpinan merupakan aspek yang penting dan harus dijaga. Dimana komunikasi yang baik dapat menghilangkan kecurigaan dan prasangka negatif. Tak hanya itu keterbukaan komunikasi akan meningkatkan rasa saling mengerti sehingga pesan yang tersampaikan mudah dipahami. Selain itu, informasi yang didapatkan yakni secara faktual dan akurat yang dapat mengurangi pencegahan kasus keselamatan pasien. Sistem pelaporan keselamatan pasien dilakukan dalam bentuk keterbukaan komunikasi yang merupakan bentuk informasi

kepada manajemen terkait kasus yang ada sehingga insiden keselamatan pasien tidak akan terjadi lagi.

3. Dimensi serah terima & pertukaran informasi

Tabel 3.19 Dimensi Serah Terima & Pertukaran Informasi

No	Tiga hal yang mengukur serah terima dan pertukaran informasi	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item F4- Kata Negatif				
	Ketika transfer pasien dari satu unit ke unit yang lain, informasi penting sering tidak tersampaikan	30	63	93	67.74%
2	Item F5- Kata Negatif				
	Selama perubahan shift, informasi perawatan pasien yang penting sering tidak tersampaikan	23	70	93	75.27%
3	Item F6- Kata Positif				
	Selama perubahan shift, ada waktu yang cukup adekuat untuk bertukar semua informasi penting perawatan pasien	82	11	93	88.17%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					77.06%

Berdasarkan hasil survey, pada dimensi dimensi serah terima dan pertukaran informasi memiliki rata-rata respon positif sebesar 77.06% yang menggambarkan bahwa dimensi kerja handsoff dan pertukaran informasi termasuk dalam kategori tinggi. Transisi merupakan proses berpindahnya pasien dari satu lingkungan ke lingkungan lain, dapat berupa perpindahan pasien dari ruang IGD ke ruang rawat inap dalam rangka pasien mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Walaupun dalam serah terima dan transisi proses serah terima di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berjalan baik masih ditemukannya informasi penting yang belum tersampaikan sehingga terjadi suatu kesalahan yang membahayakan pasien seperti pasien terjatuh dan kesalahan informasi mengenai pasien.

4. Dimensi Dukungan manajemen Rumah sakit untuk keselamatan pasien

Tabel 3.20 Dimensi Dukungan Manajemen Rumah Sakit untuk Keselamatan Pasien

No	Tiga hal yang mengukur dukungan manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item F1- Kata Positif				

	Tindakan manajemen RS menunjukkan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama	89	4	93	95.70%
2	Item F2- Kata Positif				
	Manajemen RS menyediakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan keselamatan pasien	86	7	93	92.47%
3	Item F3- Kata Negatif				
	Manajemen RS tampaknya tertarik pada keselamatan pasien hanya setelah terjadi insiden	28	65	93	69.89%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					86.02%

Berdasarkan hasil survey, dukungan manajemen Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo terhadap upaya keselamatan pasien mendapat respon positif. Pada dimensi dukungan manajemen rumah sakit terhadap keselamatan pasien sebesar 86.02% termasuk dalam kategori tinggi. Bentuk dukungan manajemen adalah mengadakan sarana dan kelengkapan untuk keselamatan pasien, adanya kebijakan manajemen terkait keselamatan pasien, memberikan motivasi staf ketika ada insiden keselamatan pasien baik itu KPC, KNC, ataupun KTD, serta mengadakan kegiatan pelatihan. Dukungan manajemen tidak akan berlangsung apabila tidak kerja sama antar pegawai.

5. Dimensi Pembelajaran Organisasi

Tabel 3.21 Dimensi Pembelajaran Organisasi

No	Tiga hal yang mengukur pembelajaran organisasi-peningkatan berkelanjutan	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A4- Kata Positif				
	Unit ini secara berkala meninjau proses kerja untuk menentukan apakah perlu perubahan meningkatkan keselamatan pasien	92	1	93	98.92%
2	Item A12- Kata Positif				

	Di unit ini, perubahan untuk meningkatkan keselamatan pasien di evaluasi untuk melihat seberapa baik mereka bekerja	89	4	93	95.70%
3	Item A14- Kata Negatif				
	Unit ini membiarkan masalah keselamatan pasien yang lama terjadi lagi	8	85	93	91.40%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					95.34%

Berdasarkan hasil survey pada dimensi pembelajaran organisasi respon positif didapatkan nilai 95.34% dengan kategori budaya tinggi. Unit-unit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan ketika ada insiden keselamatan pasien yang berupa staff di unit melakukan budaya belajar dari insiden yang telah terjadi dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut agar insiden tidak terulang Kembali.

6. Dimensi Melaporkan Peristiwa Keselamatan Pasien

Tabel 3.22 Dimensi Melaporkan Peristiwa Keselamatan Pasien

No	Dua hal yang mengukur melaporkan kejadian keselamatan pasien	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sebagian besar atau selalu	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon tidak pernah atau jarang	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item D1- Kata Positif				
	Ketika insiden kesalahan diketahui dan diperbaiki sebelum mengenai/menimpa pasien, seberapa sering ini dilaporkan? (KNC)?	56	37	93	60.22%
2	Item D2- Kata Positif				
	Ketika insiden/kesalahan sudah mengenai/menimpa pasien tetapi tidak mencederai pasien, seberapa sering ini dilaporkan? (KTC)	48	45	93	51.61%
Persentase respon positif rata-rata di 2 item					55.91%

Berdasarkan hasil survey pada dimensi melaporkan peristiwa keselamatan pasien yaitu 55.91% dalam kategori sedang. Ketika ada insiden Keselamatan pasien di

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada alurnya seharusnya dilaporkan ke atasan secara langsung untuk penanganan dan ke Komite PMKP untuk dilakukan grading matriks, dan diperlukan investigasi lanjutan untuk mendapatkan tindak lanjut dari insiden keselamatan pasien. Budaya lapor yang sedang ini diakibatkan kurangnya pemahaman petugas dalam melaporkan IKP, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelaporan insiden, ketakutan untuk melaporkan dan tingginya beban kerja.

Upaya yang dilakukan rumah sakit untuk budaya lapor dapat memperlakukan adil terhadap staf, tidak menyalahkan secara indiidu tetapi organisasi lebih fokus terhadap sistem yang berjalan akan meningkatkan budaya pelaporan. Pelaporan insiden menjadi titik awal dalam program keselamatan pasien. Melalui mekanisme pelaporan yang baik akan mampu mengidentifikasi permasalahan yang kemudian dapat dirumuskan solusi perbaikannya.

7. Dimensi Respon Terhadap Kesalahan

Tabel 3.23 Dimensi Respon Terhadap Kesalahan

No	Empat hal yang mengukur respon terhadap error	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A6- Kata Negatif				
	Di unit ini, staf merasa bahwa kesalahan mereka digunakan untuk menghukum mereka	26	67	93	72.04%
2	Item A7- Kata Positif				
	Ketika insiden dilaporkan di unit ini, sepertinya yang dicatat orangnya, bukan masalahnya	77	16	93	82.80%
3	Item A10- Kata Positif				
	Ketika staf membuat kesalahan, di unit ini focus pada pembelajaran daripada menyalahkan individu	83	10	93	89.25%
4	Item A13- Kata Negatif				
	Di unit ini, kurang mendapat dukungan untuk staf yang terlibat dalam insiden keselamatan pasien	4	89	93	95.70%
Persentase respon positif rata-rata di 4 item					89.25%

Ketika terjadi insiden, selayaknya tidak berfokus untuk mencari kesalahan individu tetapi lebih mempelajari secara sistem yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. Budaya tidak menyalahkan kepada staf perlu dikembangkan dalam menumbuhkan

budaya keselamatan pasien. Biasanya staf baru akan membuat laporan kejadian jika yakin bahwa laporan tersebut tidak akan mendapatkan hukuman atas kesalahan yang terjadi.

Lingkungan terbuka dan adil akan membantu pelaporan yang dapat menjadi pelajaran dalam keselamatan pasien. Berdasarkan hasil survey didapatkan hasil sebesar 89.25% termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa staf berani melaporkan insiden yang terjadi dan tidak ada rasa khawatir disalahkan.

8. Dimensi Kepegawaian & Kecepatan Kerja

Tabel 3.24 Dimensi Kepegawaian & Kecepatan Kerja

No	Empat hal yang mengukur kepegawaian dan kecepatan kerja	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A2- Kata Positif				
	Di unit ini, kami memiliki staf yang cukup untuk menangani beban kerja	64	29	93	68.82%
2	Item A3- Kata Negatif				
	Staf di unit ini bekerja lebih lama untuk memberikan perawatan pasien yang terbaik	25	68	93	73.12%
3	Item A5- Kata Negatif				
	Unit ini terlalu mengandalkan pada staf sementara (kontrak/honoror)	28	65	93	69.89%
4	Item A11- Kata Negatif				
	Di unit ini bekerja tergesa-gesa sehingga berdampak negatif terhadap keselamatan pasien	17	76	93	81.72%
Persentase respon positif rata-rata di 4 item					74.91%

Pada dimensi kepegawaian dan kecepatan kerja dalam survey ini respon positif yang didapatkan sebesar 74.91%, termasuk dalam kategori budaya sedang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sumber daya manusia di rumah sakit sebagai tenaga profesional pelaksana langsung pelayanan belum memenuhi kecukupan baik kuantitas dan kualitas. Namun pelayanan tetap harus dilaksanakan secara optimal. Aspek kualitas dilihat dari pendidikan dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap profesional. Kompetensi setiap profesional di rumah sakit sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) yang ditetapkan melalui Surat Penugasan Klinis (SPK) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, dimana sebelumnya profesional pemberi asuhan telah memiliki STR dan SIP. Langkah ini juga harus terintegrasi dengan

perencanaan SDM rumah sakit khususnya kompetensi Yankes dalam memenuhi standar tersebut.

9. Dimensi Supervisor / Manajer / Pimpinan Klinis untuk Keselamatan Pasien

Tabel 3.25 Dimensi Supervisor / Manajer / Pimpinan Klinis untuk Keselamatan Pasien

No	Tiga hal yang mengukur supervisor, manajer, atau pemimpin klinis dukungan untuk keselamatan pasien	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item B1- Kata Positif				
	Atasan, manajer, atau pemimpin klinis saya dengan serius mempertimbangkan saran staf untuk meningkatkan keselamatan pasien	87	6	93	93.55%
2	Item B2- Kata Negatif				
	Atasan, manajer, atau pemimpin klinis saya ingin agar kami bekerja lebih cepat di saat sibuk, walaupun harus mengambil jalan pintas	37	56	93	60.22%
3	Item B3- Kata Positif				
	Atasan, manajer, atau pemimpin klinis saya melakukan tindakan untuk mengatasi masalah keselamatan pasien yang menjadi perhatian mereka	88	5	93	94.62%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					82.80%

Pada dimensi ini respon positif yang didapatkan sebesar 82.80% yang dapat dikategorikan dalam budaya tinggi. Manajer dalam survey ini para kepala bagian, kepala ruangan, kepala unit yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan anggota dalam meyakinkan pelayanan yang aman bagi pasien. Hal tersebut dapat disebabkan para manajer sebagai lini pertama memiliki peran kritis dalam mendukung budaya keselamatan pasien dengan kepemimpinan efektif dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil survey, manajer di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah memberikan dukungannya terhadap keselamatan pasien dibuktikan dengan beberapa poin dalam kuesioner yang mendapat respon positif yang tinggi diantaranya manajer dapat mendengar dan mepertimbangkan saran dari bawahannya untuk meningkatkan keselamatan pasien. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari kepemimpinan efektif dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi keselamatan pasien

10. Dimensi Kerja Tim

Tabel 3.26 Dimensi Supervisor / Manajer / Pimpinan Klinis untuk Keselamatan Pasien

No	Tiga hal yang mengukur kerjasama tim	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A1- Kata Positif				
	Di unit ini, kami bekerja bersama sebagai tim yang efektif	88	5	93	94.62%
2	Item A8- Kata Positif				
	Jika waktu sibuk (banyak pasien) staf di unit ini saling membantu	91	2	93	97.85%
3	Item A9- Kata Negatif				
	Mereka yang bekerja di unit ini ada masalah terkait, perilaku tidak sopan	15	78	93	83.87%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					92.11%

Pada dimensi kerja tim respon positif 92.11%, yang menggambarkan bahwa dimensi kerja tim dapat dikategorikan budaya keselamatan pasien tinggi. Hal ini disebabkan karena kerja sama tim yang efektif, koordinasi staff di unit saling membantu dan menjaga adab dalam bertingkah laku. Menurut Thompson dalam setiowati (2010) mendefinisikan tim sebagai sekelompok orang saling terkait terhadap informasi, sumber daya, keterampilan, dan berusaha mencapai tujuan bersama. Kinerja kerja sama tim yang terganggu juga merupakan salah satu penyebab insiden keselamatan pasien yang merupakan kombinasi dari kegagalan sistem.

3.4. Tabel Dimensi Survey Budaya Keselamatan Pasien

Tabel 3.27 Dimensi Survey Budaya Keselamatan Pasien

No	Dimensi	Jumlah	Kategori
1	Komunikasi tentang kesalahan	98,21%	Tinggi
2	Keterbukaan Komunikasi	89,52%	Tinggi
3	Serah terima dan pertukaran informasi	77,06%	Tinggi
4	Dukungan Manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien	86,02%	Tinggi
5	Pembelajaran Organisasi-Peningkatan berkelanjutan	95,34%	Tinggi
6	Melaporkan kejadian keselamatan pasien	55,91%	Sedang
7	Respon terhadap error	89,25%	Tinggi
8	Kepegawaian dan kecepatan kerja	74,91%	Sedang
9	Dukungan Supervisor, Manajer, atau Pemimpin Klinis untuk Keselamatan Pasien	82,80%	Tinggi
10	Kerjasama Tim	92,11%	Tinggi

Rata - Rata	84,11%	Tinggi
-------------	--------	--------

Pada tabel 3.27 diatas menunjukan budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Budaya Keselamatan Pasien dikategorikan dalam budaya keselamatan yang **“TINGGI”** yaitu **“84.11%”**. Budaya keselamatan pasien tertinggi yaitu 98.21% dicapai pada dimensi **“Komunikasi Tentang Kesalahan”**. Sedangkan **“Melaporkan Kejadian Keselamatan Pasien”** menduduki kategori terendah yaitu **55.91%**

Budaya keselamatan pasien adalah persepsi yang dibagikan diantara anggota organisasi ditujukan untuk melindungi pasien dari kesalahan tata laksana maupun cedera akibat intervensi. Persepsi ini meliputi kumpulan norma, standar profesi, kebijakan, komunikasi dan tanggung jawab dalam keselamatan pasien. Budaya ini kemudian mempengaruhi keyakinan atau tindakan individu dalam memberikan pelayanan. Budaya keselamatan yang diukur dalam survey ini mengukur persepsi seluruh populasi yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang diwakili 93 sampel.

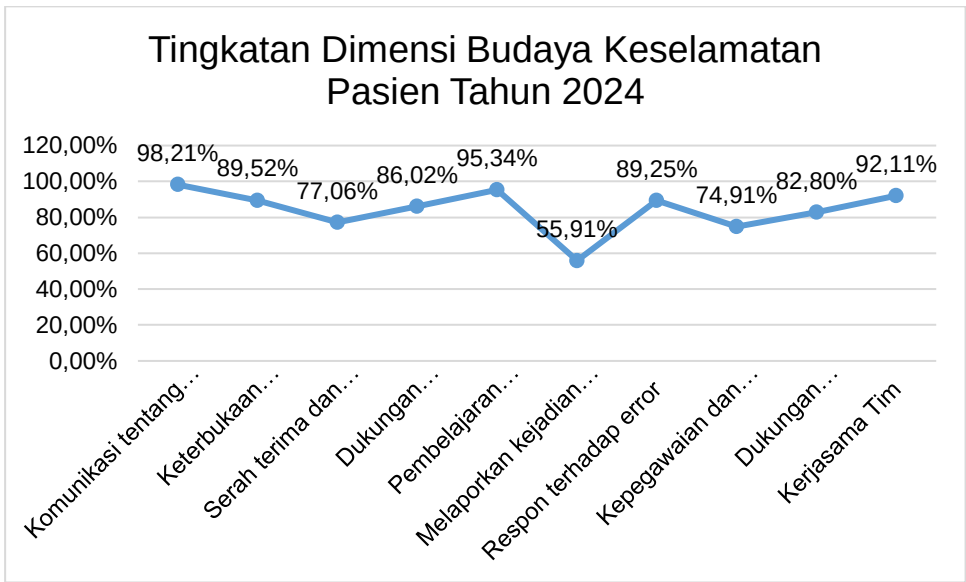
Berdasarkan hasil survey gambaran budaya keselamatan pasien secara keseluruhan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah 84.11% yang dikategorikan dalam budaya keselamatan yang tinggi. Menurut PMK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien menjelaskan bahwa membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, memimpin dan mendukung staf dalam penerapan keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam menciptakan budaya keselamatan pasien. Faktor-faktor yang membangun struktur model budaya atau iklim keselamatan pasien di berbagai negara, di berbagai unit di rumah sakit dan di berbagai kelompok profesional, misalnya dalam hal keterbukaan komunikasi, umpan balik dan komunikasi tentang error, frekuensi pelaporan kejadian, handovers (penyerahan) dan transisi, dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien, respon non-punitive (tidak menghukum) terhadap kesalahan, pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan, keseluruhan persepsi tentang keselamatan, staffing, ekspektasi manajer dalam mempromosikan keselamatan pasien, kerjasama antar unit, kerjasama dalam unit, prioritas keselamatan dan beban kerja yang aman.

Adanya dukungan manajemen dan pemimpin Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dalam membangun budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga dapat menjadi budaya organisasi dari Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sendiri. Adanya dukungan manajemen dan pemimpin Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ditunjukkan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan pasien, serta adanya penataan sistem keselamatan pasien ditambah dengan adanya pengawasan dari pihak pimpinan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang sangat dirasakan petugas memberikan kontribusi bagi terciptanya budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi terciptanya budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Pelatihan juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pelatihan keselamatan pasien terhadap pemahaman tenaga kesehatan mengenai penerapan keselamatan pasien. Selain itu penelitian menurut Sabila Diena Rosyaada menyatakan membangun budaya keselamatan pasien di rumah sakit diperlukan dukungan manajemen rumah sakit terutama peran pemimpin rumah sakit. Pelatihan merupakan metode yang terorganisir untuk memastikan bahwa individu memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam mengerjakan kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan yang lebih baik.

3.5 Grafik Dimensi Survey Budaya Keselamatan Pasien

Grafik 3.1 Tingkatan Persentase Dimensi Budaya Keselamatan Pasien



3.6 Saran Responden

No	Saran Responden
1	Selain keselamatan pasien, keselamatan pegawai atau staf perlu d tingkatkan lagi
2	Sebaiknya semua staff tidak takut untuk melaporkan IKP dan bekerja sesuai standart
3	Peran kepala ruang dalam menciptakan budaya keselamatan kerja cukup signifikan, karena karu lah yang kesehariannya berdampingan dengan petugas dan pasien. Sehingga perlu direfresh kembali terkait budaya keselamatan pasien di kalangan kepala ruang.
4	Selalu diadakan rutin sosialisasi dan evaluasi monitoring secara berkala kepada staf keseluruhan tentang budaya Keselamatan Pasien
5	Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam memperbaiki sistem yg sudah berjalan ini agar hal2 yg tidak di inginkan tidak terjadi terutama pada pasien, keluarga pasien maupun pada karyawan itu sendiri
6	Keseluruhan sudah baik, hanya saja terkadang ada kelalaian dalam bertugas dan itupun jarang sekali terjadi, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi
7	memberikan pelatihan yang sama kepada semua karyawan sehingga memiliki nilai dan kinerja yang sesuai dengan standart
8	Kurangnya sdm di suatu unit sehingga menambah beban kerja pada staff yang kekurangan sdm sehingga dapat memperbesar resiko untuk terjadinya ikp
9	Semoga bisa menjadi RS terfavorit dipasarkan dengan tingkat keselamatan pasien yang tinggi
10	peningkatan upaya perbaikan pada bed bed pasien yang rusak dikarenakan banyak ditemui bed rusak, ditambahnya SDM di unit sehingga beban kerja tidak terlalu berat

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tergolong tinggi (84.11%). Komunikasi Tentang Kesalahan 98.21% mengenai insiden di Lingkungan Rumah Sakit tergolong kuat, hal ini disebabkan oleh respon cepatnya pihak manajemen dalam menangani insiden keselamatan pasien dan juga memberikan umpan baik kepada unit serta memberi saran dan masukan terhadap unit agar kesalahan yang sama tidak berulang kembali.

Pelaporan Kejadian Keselamatan Pasien dikatakan sedang 55.91%. Budaya lapor yang sedang ini diakibatkan kurangnya pemahaman petugas dalam melaporkan IKP, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelaporan insiden, ketakutan untuk melaporkan dan tingginya beban kerja.

5.2 Saran

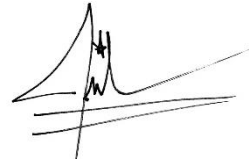
Disarankan bagi manajemen rumah sakit mempertahankan, mengembangkan program-program keselamatan pasien yang telah berjalan dan memelihara budaya keselamatan pasien yang telah berjalan serta melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penerapan budaya keselamatan pasien secara menyeluruh dengan didukung oleh kebijakan dan mengaktualisasikan program keselamatan pasien yang terancang secara sistematis di semua instalasi atau bidang secara berkesinambungan agar berjalan efektif dan efisien. Saran-saran yang membangun dan dapat diterapkan dan dilaksanakan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebaiknya segera dapat ditindaklanjuti.

Mengetahui
Direktur RS. Prima Husada Sukorejo



(dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS)

Komite Mutu



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)